



Sanidad aprueba 293 plazas PIR para 2027, una encuesta de la APA revela que el 77 % de los psicólogos ve a sus pacientes hablar de inteligencia artificial en terapia y una revisión en The Lancet Psychiatry no halla evidencia de eficacia del cannabis medicinal en ansiedad, depresión o TEPT: claves del 15 de agosto de 2026

SÁBADO 15 DE AGOSTO DE 2026

Resumen rápido del día

El Ministerio de Sanidad ha publicado en el BOE la convocatoria de Formación Sanitaria Especializada 2027, con 293 plazas PIR, 13 más que en la convocatoria anterior. Una encuesta de la Asociación Americana de Psicología (APA), difundida por medios especializados, indica que el 77 % de los psicólogos ha tenido pacientes que les hablan sobre el uso de inteligencia artificial en el contexto terapéutico. Una revisión sistemática publicada en The Lancet Psychiatry por investigadores de la Universidad de Sídney no encuentra evidencia de que el cannabis medicinal sea eficaz para tratar la ansiedad, la depresión o el trastorno de estrés postraumático. Tres estudios recientes en revistas científicas españolas e internacionales analizan, además, los tiempos de espera en Psicología Clínica, la prevención del suicidio en el ámbito universitario y la mejora del bienestar cerebral a cualquier edad.

NORMATIVA · NACIONAL

Sanidad aprueba 293 plazas PIR para la convocatoria de Formación Sanitaria Especializada de 2027

La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS) ha aprobado la oferta de plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) para 2027, que se incorporará a la orden de convocatoria publicada por el Ministerio de Sanidad en el Boletín Oficial del Estado. La oferta global asciende a 12.850 plazas para las titulaciones de Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física, lo que supone un incremento de 484 plazas respecto a la convocatoria anterior. De ese total, 293 plazas corresponden a la especialidad de Psicología Clínica (PIR), 13 más que en la convocatoria previa. La distribución por titulaciones incluye también 9.676 plazas de Medicina, 2.341 de Enfermería, 377 de Farmacia, 69 de Biología, 57 de Radiofísica Hospitalaria y 37 de Química. La propuesta se ha elaborado a partir de las necesidades planteadas por las comunidades autónomas y ha contado con los informes de la Comisión Delegada de Enfermería, el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El 10 % de las plazas se reservará para el turno de personas con discapacidad, conforme a la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias. Las pruebas selectivas se celebrarán el sábado 23 de enero de 2027, con un llamamiento a las 13:00 horas (12:00 horas en Canarias) y examen desde las 14:00 horas (13:00 horas en Canarias) en 26 localidades del territorio nacional. El ejercicio constará de 200 preguntas más 10 de reserva, con cuatro opciones de respuesta cada una, y tendrá una duración de cuatro horas y media. La calificación final combinará el resultado de la prueba, que supondrá el 90 % de la puntuación, con los méritos académicos acreditados, que representarán el 10 % restante. La convocatoria incorpora además nuevas medidas para detectar el fraude tecnológico, con equipos pasivos capaces de identificar dispositivos electrónicos ocultos mediante radiofrecuencias o campos electromagnéticos, sin funciones de interceptación de comunicaciones ni de identificación de las personas aspirantes.

Noticias internacionales

CLÍNICA · INTERNACIONAL

La APA halla que el 77 % de los psicólogos ve a sus pacientes hablar sobre el uso de inteligencia artificial en terapia

Según informa PsyPost, un informe difundido por la Asociación Americana de Psicología (APA) señala que el 77 % de los psicólogos encuestados ha tenido pacientes que les han hablado sobre el uso de inteligencia artificial con fines relacionados con la salud mental. La encuesta se realizó de forma online entre el 9 y el 26 de abril de 2026 entre profesionales con formación doctoral, licencia en vigor y atención directa a pacientes en Estados Unidos. Se invitó a participar a 22.455 profesionales colegiados por correo electrónico y, tras descartar duplicados y envíos fallidos, la muestra elegible quedó en 19.727 personas; se recibieron 1.242 respuestas completas. Según los datos recogidos por PsyPost, el 39 % de los psicólogos declaró que sus pacientes habían usado inteligencia artificial para intentar autodiagnosticarse, un 33 % señaló que la utilizaban como apoyo en su tratamiento en curso y un 35 % afirmó que algunos pacientes recurren a estos sistemas como un profesional de salud mental adicional. El informe describe también el concepto de «trampa de la complacencia» (sycophancy trap), en referencia a la tendencia de estos programas a validar el punto de vista de la persona usuaria en lugar de cuestionarlo, lo que podría reforzar pensamientos distorsionados. El 97 % de los psicólogos encuestados coincidió en que los chatbots pueden reforzar de forma involuntaria conductas o creencias delirantes, y el 94 % consideró que estos sistemas no pueden tratar afecciones de salud mental con el nivel de matiz necesario. Cerca de nueve de cada diez profesionales expresaron preocupación por que estas herramientas puedan fomentar de forma involuntaria el autolesionismo, y el 94 % dijo desconfiar de que las empresas tecnológicas protejan adecuadamente los datos de salud mental de sus pacientes. Solo el 24 % de la muestra consideró que los pacientes llegarán a preferir algún día un chatbot terapéutico frente a un profesional humano.

INVESTIGACIÓN · INTERNACIONAL

Una revisión en The Lancet Psychiatry no halla evidencia de que el cannabis medicinal sea eficaz para la ansiedad, la depresión o el TEPT

Un equipo de investigadores liderado por el doctor Jack Wilson, del Matilda Centre de la Universidad de Sídney, ha publicado en la revista The Lancet Psychiatry lo que describen como la mayor revisión realizada hasta la fecha sobre la seguridad y la eficacia de los cannabinoides en el tratamiento de trastornos de salud mental y por consumo de sustancias. El trabajo es una revisión sistemática y metaanálisis que incluye 54 ensayos clínicos aleatorizados publicados entre 1980 y 2025 en todo el mundo. Según la Universidad de Sídney, los resultados no muestran evidencia de que el cannabis medicinal sea eficaz para tratar la ansiedad, la depresión o el trastorno de estrés postraumático (TEPT). El estudio sí halla cierta evidencia de que los cannabinoides podrían ser beneficiosos en el trastorno por consumo de cannabis, el insomnio, el autismo o los tics y el síndrome de Tourette, si bien la calidad de esa evidencia se califica como baja en la mayoría de estos casos. El trabajo también encontró que el cannabis medicinal no fue eficaz para todos los trastornos por consumo de sustancias: mientras podría ayudar en la dependencia al cannabis, se asoció a un aumento de los deseos de consumo (craving) en personas con trastorno por consumo de cocaína. El doctor Wilson señaló que, aunque el estudio no analizó específicamente esta cuestión, el uso rutinario de cannabis medicinal podría estar generando más perjuicio que beneficio en algunos casos, por ejemplo al retrasar el acceso a tratamientos con mayor respaldo de evidencia. La investigación se publica en un contexto de fuerte crecimiento de las prescripciones de cannabinoides en países como Australia, Estados Unidos y Canadá, lo que ha generado preocupación entre asociaciones médicas por la falta de regulación de ese crecimiento. Los autores plantean que su revisión puede servir de base para que las autoridades reguladoras y el personal clínico tomen decisiones fundamentadas en la evidencia disponible.

Publicaciones científicas recientes

Miras-Aguilar, M. del M., Ruiz-Gutiérrez, J., Martínez-Gómez, S., Pérez-García-Abad, S., Ramos-Barrón, C., Pariente-Rodrigo, E., Piñán-Setién, L., Otero-Cabanillas, N., Priede, M. I., y González-Blanch, C. (2026). Waiting times in clinical psychology in public mental health units: Predictors of attendance at the first appointment and early dropout. *Psicothema*, 38(1), 13-22.

DOI: <https://doi.org/10.70478/psicothema.2026.38.02>

Hallazgo: El estudio, realizado con 2.765 pacientes mayores de 18 años derivados desde Atención Primaria a cuatro Unidades de Salud Mental públicas de Cantabria durante 2021, encontró una mediana de 51 días de espera para la primera consulta de Psicología Clínica y de 35 días entre la primera y la segunda consulta. El 65,6 % de la muestra superó las seis semanas de espera recomendadas como estándar clínico. La asistencia a la primera cita, registrada en el 84,6 % de la muestra, se asoció a un menor tiempo de espera y a variables como ser mujer, tener mayor edad o presentar incapacidad laboral temporal. El abandono temprano del tratamiento, registrado en el 15,8 % de quienes recibieron una segunda cita, se asoció a un mayor intervalo entre consultas, así como a ser hombre y de menor edad.

Implicación clínica: Los autores concluyen que los tiempos de espera exceden con creces los estándares recomendados y sugieren que esta situación puede representar un problema estructural que comprometa la asistencia a las consultas y la continuidad del tratamiento psicológico. El estudio plantea que puede ser útil incrementar el número de psicólogos clínicos en el sistema público y reforzar la coordinación entre Atención Primaria y las Unidades de Salud Mental, así como valorar modelos de atención escalonada, aunque los propios autores señalan que sus resultados corresponden a un área de salud concreta y que su generalización a otras zonas del país debería tomarse con cautela.

Muela, A., y García-Ormaza, J. (2026). Prevención, intervención y posvención del suicidio en el contexto universitario: retos y propuestas para una respuesta integral. *Papeles del Psicólogo/Psychologist Papers*, 47(2), 125-133.

DOI: <https://doi.org/10.70478/pap.psicol.2026.47.14>

Hallazgo: El artículo, firmado por Alexander Muela, de la Universidad del País Vasco, y Jon García-Ormaza, de la Red de Salud Mental de Bizkaia, revisa la evidencia disponible sobre salud mental y conducta suicida en la población universitaria. Según la iniciativa internacional World Mental Health International College Student, el 35 % del alumnado de primer curso presenta algún trastorno mental a lo largo de su vida y el 17,7 % declara haberse autolesionado sin intención de quitarse la vida; la prevalencia de ideación suicida a lo largo de la vida alcanza el 22,4 %, la de planificación del suicidio el 6,1 % y la de intentos de suicidio el 3,2 %. En España, el mayor estudio realizado hasta la fecha sobre salud mental universitaria, impulsado por el Ministerio de Universidades con 59.605 estudiantes participantes, encontró que la mitad del alumnado presentaba ansiedad moderada o grave y sintomatología depresiva, y que uno de cada cinco estudiantes había tenido pensamientos suicidas en las dos semanas previas a la encuesta. Los autores destacan además que más de la mitad de los estudiantes con pensamientos suicidas o conductas de autolesión no recibe ningún tipo de atención durante su etapa universitaria.

Implicación clínica: Los autores plantean que puede ser relevante que las universidades desarrollen programas integrales de prevención, con formación de tipo gatekeeper para profesorado y personal, protocolos de intervención en crisis y actuaciones de posvención tras un fallecimiento por suicidio. Señalan también que puede ser oportuno reforzar los Servicios de Atención Psicológica universitarios, cuya obligatoriedad recoge la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), dado que constatan desigualdades entre universidades en cuanto a recursos y personal especializado.

Cook, L. G., Spence, J. S., Chang, Z., Venza, E. E., Tate, A., Robertson, I. H., D'Esposito, M., Ling, G. S. F., Wigginton, J. G., y Chapman, S. B. (2026). Measuring and increasing the brain health span across adulthood: a public health imperative. Scientific Reports.

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-026-51403-3>

Hallazgo: El estudio, desarrollado por el Center for BrainHealth de la Universidad de Texas en Dallas a partir de los datos del BrainHealth Project, hizo seguimiento durante tres años a 3.966 adultos de entre 19 y 94 años que dedicaron entre 5 y 15 minutos diarios a actividades breves de entrenamiento cerebral. Los investigadores emplearon el BrainHealth Index, una medida que

combina cerca de 20 indicadores, entre ellos instrumentos validados como el Índice de Calidad del Sueño de Pittsburgh y el Cuestionario de Felicidad de Oxford, junto con tareas propias del centro centradas en habilidades de pensamiento complejo. El estudio encontró mejoras medibles en claridad de pensamiento, equilibrio emocional y sentido de conexión y propósito en todos los grupos de edad analizados, incluidas las personas en su octava y novena década de vida. Las personas que partían de las puntuaciones más bajas en el índice mostraron las mayores mejoras. Según los investigadores, el grado de participación fue el predictor más determinante de la mejora, por encima de la edad, el género o el nivel educativo.

Implicación clínica: Los autores plantean que estos resultados cuestionan la idea de que el deterioro cognitivo asociado a la edad es inevitable y sugieren que puede ser útil promover prácticas de salud cerebral de forma proactiva a cualquier edad, sin esperar a la aparición de síntomas. Señalan, no obstante, que la muestra del estudio no es plenamente representativa de la población general, ya que la mayoría de las personas participantes eran mujeres, blancas y con estudios universitarios, por lo que puede ser relevante ampliar la representación de otros grupos demográficos en investigaciones futuras.

Herramientas clínicas e instrumentos

- **Baterías digitales de seguimiento del bienestar cognitivo y emocional:** Conjuntos de pruebas breves y cuestionarios validados, aplicados de forma periódica, que permiten registrar la evolución de la claridad de pensamiento, el equilibrio emocional y el sentido de conexión y propósito de una persona a lo largo del tiempo, comparando los resultados con sus propias puntuaciones previas.
- **Protocolos digitales de cribado del riesgo suicida en el ámbito universitario:** Herramientas de detección temprana, integradas en los Servicios de Atención Psicológica de algunas universidades, orientadas a identificar señales de alarma en el alumnado y facilitar la derivación a los recursos especializados correspondientes.

Prioridades del día

Prepararse con antelación para la convocatoria PIR 2027

Con el aumento de plazas de Psicología Clínica confirmado para 2027, puede ser útil que las personas interesadas en la especialidad revisen con tiempo el histórico de plazas y el formato de la prueba selectiva para planificar su preparación.

Explorar el uso responsable de la inteligencia artificial en el proceso terapéutico

A la vista de los datos recogidos por la encuesta de la APA, puede ser relevante que los y las profesionales incorporen preguntas específicas sobre el uso de inteligencia artificial por parte de sus pacientes, y que valoren orientar hacia un uso que no sustituya la relación terapéutica ni refuerce pensamientos distorsionados.

Incorporar prácticas breves de entrenamiento cognitivo con personas adultas y mayores

A partir de los resultados del estudio del Center for BrainHealth, puede ser oportuno explorar la incorporación de actividades breves y sistemáticas de entrenamiento cognitivo en los planes de intervención con personas adultas y mayores, especialmente en aquellas con puntuaciones iniciales más bajas en medidas de bienestar cerebral.